Клинические рекомендации

Грипп у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J09** — Грипп, вызванный определенным идентифицированным вирусом гриппа **J10** — Грипп, вызванный идентифицированным вирусом гриппа **J11** — Грипп, вирус не идентифицирован
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 25.07.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского (НАСИБ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/249_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология и эпидемиология 2

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 4

3.1 Критерии диагноза 4

3.2 Этиологическая диагностика 4

3.3 Лабораторные исследования 5

3.4 Инструментальные исследования 5

4. Лечение 5

4.1 Этиотропная терапия 5

4.2 Патогенетическая и симптоматическая терапия 6

4.3 Иное лечение 6

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 7

5.1 Профилактика 7

5.2 Показания к госпитализации 7

6. Источник и актуальность 8

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 8

1. Основные положения

- Гриппом называют острое респираторное вирусное заболевание, при котором лихорадка и симптомы общей интоксикации доминируют над умеренным катаральным синдромом верхних отделов респираторного тракта.
- Диагноз подтверждается лабораторно: экспресс-тестом (ИХГ) носоглоточного мазка или ПЦР мазка из ротоглотки. В период эпидемического подъёма диагноз может быть установлен и по клинико-эпидемиологическим данным.
- Противовирусную терапию начинают **в первые 48 часов** от манифестации по клиническому подозрению, не дожидаясь лабораторного подтверждения. Ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир) показаны при тяжёлом и осложнённом течении и детям из групп риска.
- Антибактериальные препараты системного действия назначаются только при вторичных бактериальных осложнениях: синусите, тонзиллите, отите, пневмонии.
- **Признаки утяжеления**
  1. цианоз и одышка при нагрузке или в покое;
  2. кашель с примесью крови, боль или тяжесть в груди;
  3. спутанность сознания, возбуждение, судороги;
  4. повторная рвота, снижение АД и мочеотделения;
  5. высокая температура и интоксикация **более 3 дней**;
  6. у детей раннего возраста — учащённое или затруднённое дыхание, вялость, трудности с пробуждением, затруднение сосания.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Грипп (от фр. grippe — охватить; лат. influenza — вторгаться) — острое респираторное вирусное заболевание, характеризующееся лихорадкой и симптомами общей интоксикации, доминирующими над умеренным катаральным синдромом в верхних отделах респираторного тракта.

2.2 Этиология и эпидемиология

Возбудители — РНК-содержащие вирусы семейства Orthomyxoviridae, типы A, B, C и D. Подтипы вируса A определяются сочетанием гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N); эпидемическое значение для людей имеют H1, H2, H3 и N1, N2. Вирус B делится на линии Ямагата и Виктория.

Эпидемиология

1. путь передачи воздушно-капельный, возможен контактный через контаминированные поверхности;
2. восприимчивость всеобщая;
3. источник — больные в остром периоде, в том числе с лёгкой и бессимптомной формой; реконвалесценты выделяют вирус в среднем 2 недели (при гриппе A — до 22–25, при гриппе B — до 30 дней);
4. сезонность — зима и весна; эпидемии обусловлены антигенным дрейфом, пандемии — шифтом вируса A.

В 2022 г. заболеваемость гриппом детей в России составила 165,8 на 100 тыс.; наибольшая — в возрасте 1–2 лет (312,5) и до 1 года (291,4).

2.3 Классификация

1. **по типу вируса** — грипп A (A/H1N1, A/H3N2 и др.), грипп B (линии Ямагата и Виктория), грипп C
2. **по тяжести** — лёгкая, среднетяжёлая, тяжёлая (токсическая), гипертоксическая
3. **по течению** — гладкое (неосложнённое) и негладкое (с осложнениями, вторичной инфекцией, обострением хронических заболеваний)
4. **по наличию симптомов** — типичный, атипичный (стёртый, бессимптомный)
5. **по локализации поражения** — острый ринит, фарингит, трахеит, ларингит, бронхит и их сочетания (например, ринофарингит)

2.4 Клиническая картина

Грипп, как правило, начинается на фоне полного здоровья или после короткого (1–2 часа) продромального периода. Интоксикация преобладает над поражением респираторного тракта: температура уже в первые часы достигает максимума (**38,5–40 °C**).

1. **интоксикационный синдром** — озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах, боль при движении глазными яблоками, светобоязнь, слезотечение, резкая слабость; возможны головокружение, обмороки, бред, галлюцинации, судороги
2. **катаральный синдром** — выражен нерезко: затруднение носового дыхания, скудный слизисто-серозный ринит, сухость слизистых оболочек, першение в горле, сухой кашель, у старших детей — «трахеитный» с болью за грудиной; умеренная гиперемия дужек с синюшным оттенком, зернистость и инъекция сосудов мягкого нёба и задней стенки глотки
3. **геморрагический синдром** — носовые кровотечения, петехиальная сыпь на лице, шее, груди, геморрагии на слизистой оболочке рото- и носоглотки, конъюнктивах; нередко ДВС-синдром

Кровоизлияния связаны прежде всего с тромбоцитопенией: риск кровоизлияний в жизненно важные органы появляется при числе тромбоцитов **менее 100 × 10^9**, реальная угроза — **менее 50 × 10^9**.

Степени тяжести

Признак	Лёгкая	Среднетяжёлая	Тяжёлая
Температура тела	**не выше 38,5 °C**, может быть нормальной	**38,5–39,5 °C**	**выше 39,5 °C**
Интоксикация	слабо или умеренно выражена	умеренно или сильно выражена: озноб, головная боль, миалгия, адинамия, рвота	ярко выражена, энцефалическая или менингоэнцефалическая реакция
Геморрагический синдром	отсутствует	носовые кровотечения, петехиальная сыпь — умеренно и кратковременно	носовые кровотечения, сыпь, геморрагии на слизистых оболочках, кровохарканье, гематурия, нередко ДВС-синдром

Осложнения со стороны респираторного тракта

1. острый стенозирующий ларинготрахеит — развивается в первые часы на фоне гипертермии и интоксикации, особенно у детей с респираторным аллергозом и ларингитом в анамнезе;
2. острый бронхит (20–30% случаев), у каждого пятого ребёнка — с обструктивным синдромом;
3. пневмония: в первые 4–5 дней — диффузная вирусная с тяжёлой гипоксемией и ОРДС; в конце первой — начале второй недели — вирусно-бактериальная, после короткого светлого промежутка.

Поражения ЛОР-органов (отит, евстахиит, синусит и др.) развиваются с участием бактериальной микрофлоры на любом этапе заболевания. Возможны невриты, преимущественно лицевого и тройничного нервов.

Наиболее тяжёлые осложнения (токсикоз с полиорганным поражением)

1. инфекционно-токсическая энцефалопатия (нейротоксикоз);
2. ОРДС;
3. синдром Гассера, острая почечная недостаточность;
4. синдром Рея;
5. миокардит и синдром Кишша;
6. синдром Уотерхауса — Фридериксена;
7. ДВС-синдром.

Примерно в 3–5% случаев, преимущественно при шифтовом варианте вируса, возможно внезапное ухудшение на любой день болезни, даже на фоне улучшения.

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза: острое начало, высокая стойкая лихорадка с первых часов, интоксикация; контакт с больным гриппом или ОРВИ, с инфицированными животными или птицами;
2. физикального обследования: умеренный или скудный катаральный синдром (ринофарингит, ларингит, трахеит), лихорадка, возможен геморрагический синдром;
3. подтверждения одним из лабораторных методов этиологической диагностики.

Подтверждённым считается случай после лабораторного подтверждения; в период эпидемического подъёма окончательный диагноз может быть установлен и по клиническим и эпидемиологическим данным.

3.2 Этиологическая диагностика

Иммунохроматографический экспресс-тест носоглоточного мазка на вирусы гриппа A и B — для ранней диагностики на амбулаторном и стационарном этапах; чувствительность 73,7–86,8%, специфичность 97,6–100%. Особенно актуален при невозможности ПЦР.

Молекулярно-биологическое исследование (ПЦР) мазка со слизистой оболочки ротоглотки на вирус гриппа является стандартом диагностики; чаще используется при госпитализации.

Для дифференциальной диагностики и выявления сочетанных инфекций проводят ПЦР мазков носо- и ротоглотки на другие респираторные вирусы.

1. SARS-CoV-2 и сезонные коронавирусы;
2. вирусы парагриппа;
3. риновирусы и аденовирусы;
4. респираторно-синцитиальный вирус;
5. бокавирусы и метапневмовирусы.

Кому

1. всем госпитализированным;
2. амбулаторно — при тяжёлом течении, осложнениях, факторах риска.

Серологическая диагностика (ИФА) применяется ретроспективно при четырёхкратном нарастании титров специфических IgG, а также в научных и эпидемиологических целях.

3.3 Лабораторные исследования

Общий анализ крови показан при среднетяжёлом и тяжёлом гриппе.

1. **лейкопения** — прогностически неблагоприятна: высокий риск вирусной пневмонии
2. **лейкоцитоз с нейтрофилёзом и сдвигом влево** — высокий риск вирусно-бактериальной пневмонии и других бактериальных осложнений
3. **тяжёлое течение** — лейкоциты **более 12 × 10^9/л** или **менее 3 × 10^9/л**, незрелых форм нейтрофилов более 10%
4. **снижение гемоглобина и тромбоцитов** — требует исключить синдром Гассера; панцитопения — гемофагоцитарный синдром

При подозрении на бактериальные осложнения или микст-инфекцию исследуют СРБ и прокальцитонин: диагностическим считают повышение более чем на 2 стандартных отклонения; одновременное повышение обоих показателей точнее выявляет вторичную бактериальную пневмонию.

Общий анализ мочи — при подозрении на поражение почек.

Биохимический анализ крови — при тяжёлом или негладком течении: мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, ЛДГ, билирубин, КФК, глюкоза; позволяет диагностировать рабдомиолиз, синдром Рея, кардиальные осложнения.

Коагулограмма — при геморрагических проявлениях для диагностики ДВС-синдрома; **натрий, калий, хлориды** — при тяжёлом течении: синдром Гассера, электролитные нарушения при обезвоживании.

3.4 Инструментальные исследования

Пульсоксиметрия выполняется на всех этапах помощи при подозрении на поражение нижних дыхательных путей, осложнённом течении, дыхательной недостаточности.

При подозрении на пневмонию выполняют рентгенографию лёгких или КТ органов грудной клетки; при подозрении на вирусную пневмонию (двусторонняя пневмония в первые 4 суток) предпочтительна КТ.

1. **ЭКГ** — при подозрении на поражение сердца, нарушения ритма и проводимости
2. **эхокардиография** — при сопутствующей кардиологической патологии
3. **ЭЭГ** — при неврологической симптоматике: судорогах, подозрении на отёк мозга, менингит, энцефалит

При подозрении на поражение органов показаны консультации кардиолога, невролога, оториноларинголога; при тяжёлом течении и осложнениях — осмотр анестезиолога-реаниматолога для своевременного перевода в отделение реанимации.

---

4. Лечение

4.1 Этиотропная терапия

Противовирусные препараты начинают **в первые 48 часов** после манифестации всем пациентам с симптомами гриппа.

1. основание — клиническое подозрение в сезон подъёма заболеваемости или контакт с больным гриппом;
2. лабораторного подтверждения не дожидаются;
3. вакцинация в текущем сезоне и тяжесть болезни на решение не влияют;
4. при тяжёлом течении и факторах риска терапию начинают на любом этапе разгара болезни.

Ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир и занамивир — показаны при тяжёлом гриппе, среднетяжёлом с осложнённым течением и детям из групп риска при любой тяжести. При частом применении формируется резистентность.

1. осельтамивир: **с 1 года**;
2. #осельтамивир детям **старше 14 дней и младше 1 года**: при лабораторно подтверждённом тяжёлом или осложнённом гриппе 3 мг/кг на приём 2 раза в сутки по решению консилиума и с согласия законного представителя;
3. занамивир: **старше 5 лет** при тяжёлом гриппе, **в первые 36 часов**; с осторожностью при бронхоспазме.

Осельтамивир и занамивир не рекомендуются как препараты первой линии при лёгком и среднетяжёлом гриппе у детей без преморбидной патологии и факторов риска: это предотвращает формирование резистентности.

Препараты при неосложнённом гриппе без факторов риска

1. балоксавир марбоксил: однократно внутрь, при массе тела **от 20 кг**, в том числе в группах риска;
2. умифеновир: **с 2 лет** (порошок для суспензии), таблетки **с 3 лет**, капсулы **с 6 лет**.

1. Кагоцел: **старше 3 лет**;
2. имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты: **с 3 лет**, начать желательно не позднее 2-го дня болезни;
3. инозин пранобекс: **с 3 лет**.

Римантадин не рекомендуется при любой тяжести гриппа: доказана резистентность большинства штаммов.

4.2 Патогенетическая и симптоматическая терапия

Инфузионная терапия растворами электролитов и углеводов проводится при неэффективности оральной регидратации у детей с тяжёлым гриппом, стойкой лихорадкой, выраженной интоксикацией.

Объём рассчитывают по физиологической потребности и патологическим потерям: избыток жидкости, особенно изотонического раствора натрия хлорида, опасен отёком лёгких и мозга.

При фебрильной лихорадке применяют парацетамол или ибупрофен; при судорогах в анамнезе или на фоне болезни снижают и субфебрильную температуру.

1. парацетамол: суспензия **с 3 месяцев**, таблетки **с 3 лет**;
2. ибупрофен: суспензия **с 3 месяцев**, таблетки 200 мг **с 6 лет**, 400 мг **с 12 лет**.

При затруднённом дыхании и выраженном рините применяют деконгестанты и другие назальные препараты: они уменьшают отёк слизистой оболочки полости носа и улучшают отток из околоносовых пазух.

1. **сухой навязчивый кашель** — бутамират; возрастные ограничения зависят от лекарственной формы
2. **трахеит, бронхит, пневмония** — амброксол для облегчения отхождения мокроты

Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых препаратов не рекомендуется.

4.3 Иное лечение

При лёгком гриппе без факторов риска, подозрении на сочетанную вирусную инфекцию или признаках лёгкого иммунодефицита возможно применение иммуностимуляторов.

1. интерферон альфа-2b: с первых дней жизни, в том числе недоношенным, в ректальных суппозиториях;
2. меглюмина акридонацетат: **с 4 лет**;
3. Анаферон детский: **с 1 месяца**; Эргоферон: **с 6 месяцев**.

Антибактериальные препараты системного действия применяют только при вторичных бактериальных осложнениях, по клиническим рекомендациям соответствующих нозологий и с учётом чувствительности возбудителя.

Осложнения вирусно-бактериальной этиологии

1. синусит;
2. тонзиллит;
3. отит;
4. пневмония;
5. инфекция мочевыводящих путей.

При пневмонии, развившейся **с 5-х суток** гриппа, антибиотик назначают и без выделения возбудителя.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Диспансерное наблюдение при неосложнённом гриппе не показано. Больного изолируют дома, в изоляторе или боксе до клинического выздоровления; проводят влажную уборку и проветривание, выделяют отдельную посуду, ухаживающие моют руки и носят маски. Карантин для контактных не вводится.

Вакцинация проводится всем, не имеющим противопоказаний, в предэпидемический период; по национальному календарю прививают детей **с 6 месяцев**.

Вакцину против гриппа можно вводить с любым интервалом до или после других неживых и живых вакцин, кроме БЦЖ.

Непривитым в текущем сезоне детям после контакта с больным гриппом или ОРИ показана экстренная постконтактная химиопрофилактика; детям с факторами риска — обязательно.

1. ингибиторы нейраминидазы: если с контакта прошло **не более 48 часов**, только непривитым детям из группы риска;
2. балоксавир марбоксил: однократно **не позднее 48 часов** от контакта, при массе тела **от 20 кг**.

1. Кагоцел: **с 3 лет**; меглюмина акридонацетат: **старше 4 лет**; Анаферон детский: **с 1 месяца**;
2. интерферон альфа-2b интраназально: с первых дней жизни, 5 дней (мазь — старше 1 года); умифеновир — по инструкции.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. выраженная интоксикация;
2. геморрагический синдром, ДВС-синдром, синдром Гассера с острой почечной недостаточностью;
3. гемодинамическая нестабильность: холодные конечности, цианоз, мраморность кожи, коллапс, кома;
4. выраженная дыхательная недостаточность, признаки пневмонии и ОРДС;
5. новорождённые и дети первых лет жизни со среднетяжёлым осложнённым гриппом или обострением сопутствующих заболеваний.

Детей госпитализируют в инфекционные стационары, имеющие отделения реанимации и интенсивной терапии.

Критерии выписки

1. стабилизация состояния;
2. нормализация температуры.

Факторы риска неблагоприятного исхода

1. возраст **до 5 лет**, особенно **младше 2 лет**;
2. бронхиальная астма, пороки развития бронхолёгочной системы, муковисцидоз;
3. пороки и воспалительные заболевания сердца;
4. сахарный диабет, ожирение;
5. заболевания печени и почек, наследственные и митохондриальные нарушения обмена;
6. ВИЧ-инфекция, врождённые и приобретённые иммунодефициты;
7. неврологические нарушения.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Грипп»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 25.07.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2028 года
Код в рубрикаторе	249_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням; Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Первая рекомендация раздела 3.1.1 предписывает ингибиторы нейраминидазы в первые 48 часов «всем пациентам с симптомами гриппа», а следующая не рекомендует осельтамивир и занамивир как препараты первой линии при лёгком и среднетяжёлом гриппе без факторов риска.
- Единицы измерения в разделах 1.6 и 2.3: тромбоциты «100 × 10^9/мл» (вместо /л), билирубин «более 50 ммоль/л» и креатинин «более 0,2 мг/л» — значения в указанных единицах физиологически невозможны.